



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : بدرالصباح عبدالجليل عبدالعزيز محمد

العنوان : زاوية النجار مركز
قليوب

الحي / المدينة : قليوب

المحافظة : القليوبية

تاريخ تسجيل الإستمارة : 23-09-2026

رقم البطاقة : 27810011403585 رقم التليفون : 01091429723

العمر(تاريخ الميلاد) : 01-10-1978 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تديمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندي حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس
وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: بدرا الصباح عبد الجليل عبدالعزيز محمد National ID: 27810011403585	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية الأردن
بطاقة تحقيق الشخصية

بدر الصباح
عبد الجليل عبدالعزيز محمد عمر
زاوية النجار
مركز قلوب - القنيطرة

١٩٧٨/١

JT6280509

٢٧٨١٠٠١١٤٠٣٥٨٥

٢٧٨١٠٠١١٤٠٣٥٨٥

صلى



٢٠٢٣/٠٧ ٢٧٨١٠٠١١٤٠٣٥٨٥

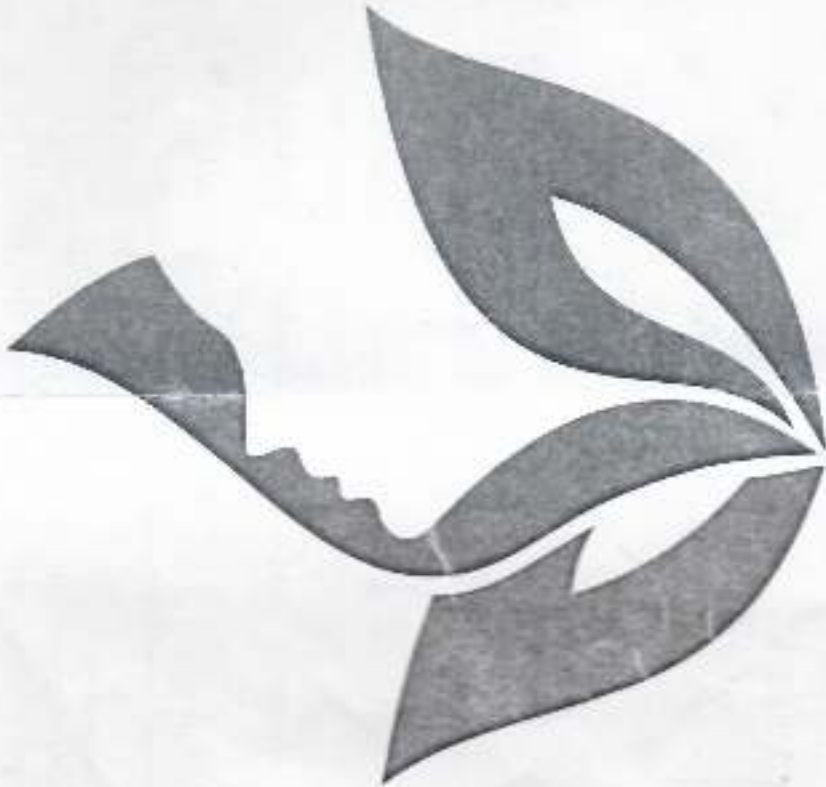
حاصنه علي دبلود زراعه



انثى مسلمة متروجة
حميد كامل محمد شهاب الدين
البطاقة سارية حتى ٢٠٣٠/٠٧/٢٠

١١





الاسم: **د. الصباح أبو الطيب**
الرقم القومي: **٢٥٨٥ - ١١ - ٢٧٨١**
رقم التليفون: **٢٧٦٧٨٨**
مساهمة بالتوعية
مساهمة بالتوعية والفحص الإكلينيكي

قياس ضغط	قياس السكر العشوائي	مؤشر كتلة الجسم	الطول	الوزن

فكري نفسك باستمرار بموعد الفحص الذاتي شهرياً

2019	سبتمبر	أغسطس	2019	يوليو
2019	ديسمبر	نوفمبر	2019	أكتوبر
2020	مارس	فبراير	2020	يناير
2020	يوليو	مايو	2020	أبريل
2020	سبتمبر	أغسطس	2020	يوليو
2020	ديسمبر	نوفمبر	2020	أكتوبر
2021	مارس	فبراير	2021	يناير
2021	يونيو	مايو	2021	أبريل

- حافظي علي قياس السكر والضغط مرة كل ٦ شهور.
- إذا كنتي في سن الزواج أو الإنجاب، استقبلي باللائام طبيب للتقييم الأسرة.
- إطمئي، الكشف المبكر يساعد في السيطرة على الأمراض، وزيادة نسب الشفاء.
موعد الفحص القادم:
المكان المحددة له للتقييم:
توقيع الطبيب:
موعد التقييم:



مركز النور المحمدي للأشعة

Al-Nour Al-Mohammady Radiological Center

مركز مفتوح - أشعة مقطعية - موجات صوتية - دبلر ملون
مركز مفتوح - أشعة مقطعية - موجات صوتية - دبلر ملون
Al-Nour Al-Mohammady Radiological Center - Al-Nour Al-Mohammady Radiological Center
Al-Nour Al-Mohammady Radiological Center - Al-Nour Al-Mohammady Radiological Center

Dear Prof. Dr :

Date : 29 August 2026

Patient's name: بدر الصباح

BILATERAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND BREAST US

- ACR b breast parenchymal density of right breast
- No gross speculated masses or pathological calcifications on right side
- Left breast moderate diffuse oedma with underlying nearly diffuse parenchymal infiltration with associated pathological calcifications and associated large irregular spiculated high density lesion seen mainly at upper areolar region seen by US as irregular spiculated heterogeneous hypoechoic solid lesion measuring about 4.4x3 cm surrounded with parenchymal oedma and infiltration and nipple retraction
- No solid or cystic lesions seen by US on RT side
- LT sided pathological level 1, 11 and 111 axillary LNS largest measures about 3.3x1.8 cm
- RT sided no gross suspicious axillary LNS

CONCLUSION :-

- BIRADS V LT breast picture of locally advanced malignant process as described for further management
- RT breast no gross suspicious lesions

MUCH OBLIGED YOURS.

Dr. OMNIA MOKHTAR M.D

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION



الهيئة العامة للتأمين الصحي
الإدارة المركزية لتنظيم المعلومات و التحول
الرقمي

رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار: 2026-9-2

جهة الاصدار: فرع القليوبية

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل" و كذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسي" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعية
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي
والبحث تبين أن

السيد (ة) بدر الصباح عبدالجليل عبدالعزيز بطاقة رقم 27810011403585
تليفون رقم: 01276984268

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
بغير من الفئات غير المتكفلة بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون اني مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ طباعه: 2026-9-2

الموقع المختص

سهم عيسى

قاعدة مركز نظم المعلومات
يتمتع...



مسجل 2067728

الخطاب ساري لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ الاصدار الا في حالة تغيير حالة المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو
وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التربية والتعليم

الإدارة المركزية لتنظيم المعلومات و التحول الرقمي

رقم الاصل 095566

[illegible]

10/6/20

1500000000

0.320461

J-16280509

0Y 04 31 10 01 YAA

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين



Dr. ✓
29/9/2026

Signature:
Dr. Nermine Nabil M.D

Diagnosis: Left breast mass, Tru-cut biopsy:
Invasive duct carcinoma (NST), Grade II.

Immunohistochemical Result
ER: Strong nuclear staining in 90% of tumor cells (Allred Score 8/8).
PR: Weak nuclear staining in 15% of tumor cells (Allred Score 4/8).
Her2: Weak incomplete membranous staining in > 10% of tumor cells (score 1+).
Ki67: Positive nuclear staining of 60% of tumor cells.

Microscopic picture:
Section examined revealed core of tumor showing invasive duct carcinoma of no special type (NST). The tumor forms nests, tubules and cribriform pattern infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showing moderate anaplasia and moderate tendency to from tubules. There is moderate number of mitotic figures.

Immunohistochemical Technique:
Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against ER-PR-Her2-Ki67

Gross pathology:
Multiple fragmented grayish white tissue cores up to 1cm long, totally submitted.

Clinical diagnosis: Left breast mass

Nature of specimen: tru-cut biopsy

Referred by: د. هبة عزام

Department: صدره

Hospital no:

Request type: ملانر

عبدالعزيز

Patient name: نير الصياح عبداللطيف

Age: 48 years

Sex: female

PATHOLOGY DEPARTMENT HISTOPATHOLOGICAL REPORT

قسم الباثولوجي

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي
والأمراض المعدية





Date : 29 August 2026

Dear Prof. Dr :
 Patient's name: **بدر الصالح**

BILATERAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND BREAST U/S

- ACR b breast parenchymal density of right breast
- No gross speculated masses or pathological calcifications on right side
- Left breast moderate diffuse oedema with underlying nearly diffuse parenchymal infiltration with associated pathological calcifications and associated large irregular spiculated high density lesion seen mainly at upper areolar region seen by US as irregular spiculated heterogeneous hypoechoic solid lesion measuring about 4.4x3 cm surrounded with parenchymal oedema and infiltration and nipple retraction
- No solid or cystic lesions seen by US on RT side
- LT sided pathological level I, II and III axillary LNS largest measures about 3.3x1.8 cm.
- RT sided no gross suspicious axillary LNS

CONCLUSION :-

- BIRADS V LT breast picture of locally advanced malignant process as described for further management
- RT breast no gross suspicious lesions

MUCH OBLIGED YOURS,
 Dr. OMNIA MOKHTAR M.D

تعرفني على كيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي

الخطوة الأولى (أمام المرأة)

- انظري إلى الثديين في المرأة مع وضع اليدين في وضع مستقيم على الجانبين ثم وضع اليدين على الوسط.

- تأكدي بالنظر إلى شكل ولون وحجم الثديين، وأنه هو المعتاد بالنسبة لك في دون تغيير أو دون اختلاف بين الثديين.

- لاحظي وجود أي من العلامات التالية بأي من الثديين:

بروز الأوردة
تغير في الشكل أو الحجم
حدوث تجويف
طفح

تجاعيد بالجلد تحول الجلد لما يشبه قشر البرتقال
الإحمرار
تراجع أو تغيير في اتجاه الحلمة أو الحلمة

الخطوة الثانية (أمام المرأة)

- أرفعي يديكي إلى أعلى وتأكدي من عدم وجود أي من التغييرات السابقة

الخطوة الثالثة (أمام المرأة)

- أثناء رفع يديكي إلى أعلى، لاحظي خروج أي إفرازات غير طبيعية أو دم من الحلمتين اليمنى أو اليسرى

إفرازات غير طبيعية أو دم

الخطوة الرابعة (على السرير)

- رستلقي على السرير، استخدم يدي اليمنى لفحص الثدي الأيمن واليد اليسرى لفحص الثدي الأيسر.

- باستخدام أطراف أصابعك و من خلال حركة دائرية، قومي بفحص الثدي (الجلد والأنسجة).

- تأكدي من فحص الثدي بالكامل من أعلى إلى أسفل، ومن جانب إلى جانب - من عظمة الترقوة إلى أعلى بطنك، ومن الإبط إلى منتصف الصدر.

- عتني لتأكدي من فحص الثدي بالكامل، يمكنك أن تبداي من الحلمة ثم تتحركي في دوائر أكبر وأكبر حتى تصلين إلى المنطقة الخارجية للثدي.

- يمكنك أيضا تحريك أصابعك لأعلى ولأسفل رأسياً.

- لاحظي الإحساس بأي من العلامات التالية:

الشعور بأورام بالإبط
الشعور بسمك عام



الدم بالثدي
ورم محسوس

الخطوة الخامسة (أثناء الإستحمام)

- أعيدي الفحص السابق بنفس الطريقة المذكورة أثناء الإستحمام والجلد مبتل.

- أمضلي ثوبك لتقومين بالفحص الذاتي للثدي بعد آخر يوم في الدورة الشهرية أو في حالة انقطاع الدورة الشهرية. جدي يوم ثابت شهرياً لإجراء الفحص.

- في حال ملاحظة أي من العلامات السابقة، توجهي إلى عيادة صحة المرأة بالوحدة الصحية.